

INDICADO POR: Internet(☒) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

ALEXANDRE SANTOS SILVA

IDADE: 54 PESO: 90 ALTURA: 177 PROFISSÃO: militar (Apos.)SINTOMAS: somnolência diurna / causaco / mmiI potencializadoQUEIXAS: Desperta de madrugada (2h até 5h) dorme (10h)MEDICAMENTOS: suastatina / Naprox / atenolol / Aclodipina / Risperidona

Exitalopram.

MÉDICO: Dr. Michel / Dr. Claudio Sanchez ultrassomMARCAPASSO: () S (☒) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (☒) NEXERCÍCIO FÍSICO: Não fazHORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (21:30)HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 6hCOCHILHO (☒) S () N Bast. DORME ACOMPANHADO: (☒) S () N () EVENTUALMENTE esposa noivaTEM FILHOS: (☒) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (☒) N PET NO QUARTO: () S (☒) NBEBIDA ALCOÓLICA: (☒) S () X NA SEMANA () N só final semana.FUMO: () S () MAÇO/DIA (☒) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: utiliza 4 travessões.TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 3X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 39,3 SPO2: 79%PATOLOGIAS ASSOCIADAS: não / o intestino funciona muito
doe lombar / esquece fatos completosCIRURGIAS: (N) NASAL (☒) AMIGDALECTOMIA (Retirou)

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (☒) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

26/08/25 Avaliaçãomarc. D. Pullatfuva.03/07/25 / Ainda acordava as 3hs da manhã.Dorme só a noiteMelhora do epilépsia mmiI.Mais. encomoda mas n machucaSolicito pl 40 n. de travessões pl 2.P= 8,2 cmH₂OIAH= 40 2,4 e/evm. de uso: 4h32'fuva.23/07/25 P= 8,4 cmH₂OIAH= 2,0 e/evm. de uso = 4h20'

NOME:	ALEXANDRE SANTOS SILVA	DATA: 11-06-2025
IDADE:	54 anos	
SEXO:	Masculino	
SOLICITANTE:	Claudio Watanabe	

POLISSONOGRAFIA

Aspectos Técnicos:

Estudo polissonográfico noturno domiciliar realizado com equipamento NeuroVirtual® BWMini PSG, seguindo normas e diretrizes recomendadas pela AASM – Academia Americana de Medicina do Sono.
 Realizada avaliação simultânea dos parâmetros abaixo:

- Eletroencefalograma: Montagem em F3-M2, C3-M2, O1-M2, F4-M1, C4-M1, O2-M1
- Eletrooculograma
- Eletromiograma: Região submentoniana e m. tibial anterior bilateral
- Ronco
- Fluxo aéreo oral e nasal através de termistor e canula nasal de pressão
- Posição corporal
- Análise pletismográfica de esforço respiratório torácico e abdominal
- Saturação arterial de oxigênio (SpO2), eletrocardiograma (ECG) e frequência cardíaca

Resultados:

Exame iniciado 11/06/2025 21.00 horas e concluído 12/06/2025 05.00 horas.

A latência para início do sono foi de 5,0 minutos

O tempo total de sono foi de 480,0 minutos, com eficiência do sono (TTS / TTR)* de 85,3%.

A distribuição do sono mostrou: 46,4% de estágio N1, 50,4% de estágio N2, 3,2% de estágio N3 e 0% de sono REM. No período total de sono permaneceu 70,5 minutos em vigília.

Ocorreram 314 despertares tendo o índice de (39,3/hora).
 O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de 0,0/hora.

O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de 29,4/h.

O índice de apneia/hipopneia foi de 29,4/h sendo 8,2 apneia/hora e 21,2 hipopneia/hora.

O número total de eventos respiratórios foi de 200, sendo 144 hipopneias, 56 apnéias obstrutivas, 0 apnéias centrais e 0 apnéias mistas e 0 RERAS.

A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 92%, sendo a saturação média de 91 % e a mínima de 79%.

(*) TTS ⇨ Tempo Total de Sono TTR ⇨ Tempo Total de Registro